

CONSIDERACIONES LEGALES DE LA MEDICINA URGENTE

Pablo Arraiza Jiménez, Francisco Javier Arraiza Jiménez.

1. INTRODUCCIÓN

- La normativa legal que de manera más directa afecta al profesional de la medicina es aquella que aborda la regulación de los aspectos relacionados con la responsabilidad en la que pudiera incurrir en el desempeño de su trabajo.
- Dicha responsabilidad puede ser de dos tipos:
 - Civil**, esto es, de indemnización de los perjuicios que eventualmente pudieran derivarse de la intervención médica, si bien resulta prácticamente ajena al profesional integrado en el sistema público de salud, por razón de la responsabilidad directa de la Administración Pública; y para el resto del personal sanitario, el riesgo de incurrir en responsabilidad civil resulta de ordinario cubierto mediante la contratación del correspondiente seguro.
 - Penal**, esto es, de la eventual imposición de una pena, ya sea de prisión, pecuniaria o de inhabilitación profesional, por razón de la comisión de una conducta, ya sea activa u omisiva, prevista en el Código Penal como constitutiva de delito.
- La actuación del profesional de la medicina en situaciones urgentes se mueve en una permanente tensión entre el deber de salvaguarda de la salud de las personas en un concreto y breve lapso temporal en el que por diversas causas se ve amenazada, y el temor a incurrir en algún tipo de responsabilidad derivada de una intervención a la que resulta inherente la escasez de tiempo para adoptar decisiones relevantes. Precisamente esa tensión constituye una potencial fuente de actitudes defensivas ineficientes e incluso perjudiciales para el fin de la atención sanitaria, motivadas por el temor a las eventuales consecuencias negativas que determinadas decisiones pudieran generar al profesional en caso de no producir el resultado esperado. Para evitar o reducir en la medida de lo posible este riesgo se han ido desarrollando protocolos de actuación, debidamente refrendados por los agentes implicados, que de un lado ofrecen la utilidad de servir de guía a los profesionales en su labor, y de otro les propicia un marco de seguridad jurídica que le permite centrar sus esfuerzos en la atención médica al margen de cualquier otra consideración.

2. LA “LEX ARTIS”

- Se entiende por tal el conjunto de las prevenciones que debe adoptar el profesional sanitario con la finalidad de adecuar su intervención a la obtención del resultado más favorable posible en unas determinadas circunstancias.
- La manera más idónea de evitar o atenuar la potencial influencia negativa del temor a la responsabilidad del profesional sanitario de emergencias en su intervención es proveerle de un conocimiento adecuado de sus competencias, para lo que resulta de gran utilidad la elaboración y difusión de protocolos de actuación, y de la verdadera entidad del riesgo personal asumido con las decisiones adoptadas en el curso de su intervención.
- Las peculiares características de las situaciones de urgencia han de ser objeto de una especial ponderación a la hora de enjuiciar la eventual responsabilidad del profesional sanitario, tanto por la premura de su intervención, como por la gravedad de la situación que la demanda, como de la frecuente imposibilidad de obtener del paciente un

consentimiento informado que le haga copartícipe de los riesgos asociados a la concreta decisión médica adoptada.

- La responsabilidad médica es de medios y no de resultado, lo que supone que no deriva del hecho en sí del perjuicio que haya podido derivarse de una actuación, sino que requiere además la prueba, por parte del perjudicado, de la negligencia del profesional y de la relación de causalidad entre su intervención y el daño. Así, para que el acto médico dé lugar a responsabilidad ha de quedar plenamente acreditado en el hipotético proceso judicial que ha sido realizado sin la observancia de las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo, y ha de resultar de una certeza probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o probabilidades, aunque no siempre se requiere la absoluta certeza, por ser suficiente un juicio de probabilidad cualificada. Si bien, en ocasiones los tribunales admiten la inversión de la carga de la prueba, para imponérsela al profesional médico en los supuestos del denominado “daño médico desproporcionado”, que es aquel no previsto ni explicable en la esfera de la actuación profesional médico-sanitaria.

3. INTERNAMIENTO PSIQUIÁTRICO URGENTE

- El internamiento de un paciente psiquiátrico puede tener lugar de manera voluntaria, lo que por las características de la patología psiquiátrica no sucederá con frecuencia en situaciones urgentes, o bien sin el consentimiento del enfermo. En caso de no ser consentido, siempre será precisa la intervención judicial, que puede ser de dos tipos:
 - No urgente**, supuesto en el que con carácter previo al internamiento se tramita un procedimiento ante los juzgados de familia, lo que supone la intervención ordinaria del servicio de psiquiatría y excluye la de los servicios de urgencias o emergencias sanitarias.
 - Urgente**, regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en el que la decisión médica es anterior en el tiempo al internamiento, al primar la salud del paciente sobre su propia voluntad, en aquellos casos en los que el padecimiento psiquiátrico le impide tomar la decisión por sí mismo, y concurren razones de urgencia que hacen necesaria la adopción de la medida de forma inmediata. En estos casos la intervención de los servicios de urgencias y/o emergencias es común, y el médico debe tomar la decisión de traslado del paciente al centro hospitalario de manera autónoma y sin precisar de autorización judicial, para lo que cuenta con la capacidad de ordenar a los cuerpos y fuerzas de seguridad el auxilio que resulte preciso para reducir la eventual resistencia que pueda ofrecer el paciente, a cuyo domicilio puede acceder, con autorización judicial e incluso sin ella en caso de necesidad. En caso de acordar el servicio de psiquiatría el ingreso del paciente, la autoridad judicial debe decidir, en un plazo máximo de 72 horas desde que se lo comunique el centro, si procede la ratificación de la medida o su alzamiento, previo examen personal del paciente y tras valorar el correspondiente informe del médico forense y cualesquiera otras pruebas que el juez estime relevantes para el caso. El informe del facultativo interviniente es crucial para que el médico forense pueda evaluar adecuadamente las circunstancias que han llevado al traslado, especialmente cuando resulta precisa la sedación del paciente, supuesto en el que ni el forense ni el juez van a poder percibir por sí mismos las circunstancias que han motivado la intervención dirigida al internamiento.

4. VIOLENCIA DE GÉNERO

- Los servicios de urgencias y de emergencias sanitarias se enfrentan con frecuencia a escenarios de violencia de género en los que, además de prestar a la víctima la atención sanitaria que la situación de urgencia requiera, han de realizar un esfuerzo adicional en la gestión de su intervención que puede resultar esencial para facilitar el éxito del procedimiento judicial y, en definitiva, una adecuada protección de la víctima.
- La intervención de los servicios de urgencias y de emergencias sanitarias tendrá lugar cuando se produzca un episodio de explosión de violencia, en el que junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad van a desempeñar un papel crucial tanto en la atención directa de la víctima como en la gestión psicológica del contexto en el que se ha producido la agresión, así como en la constatación de los hechos que pudieran conducir a una condena penal.
- El médico deberá valorar adecuadamente las circunstancias que se le presentan para poder detectar debidamente un cuadro de violencia de género, sin temor a invadir la intimidad de la posible víctima y abordando la situación desde un punto de vista no exclusivamente médico, sino también social y cultural. Además, ha de tratar de soslayar la posible opacidad de la víctima por razones de vergüenza o por falta de reconocimiento del maltrato, y procurar su confianza en el sistema para poder obtener su colaboración activa de cara al futuro proceso judicial.
- El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a quienes por razón de su profesión tengan conocimiento de la perpetración de un delito el deber de ponerlo de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Juzgado de guardia para que se tramite el correspondiente procedimiento penal, sin perjuicio de poder recabar además el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad que resulte preciso, en particular para garantizar la seguridad de la víctima. En caso de finalizar la asistencia sin traslado a un centro médico, el facultativo deberá elaborar el correspondiente informe y remitirlo al Juzgado de Guardia, a ser posible a través de medios informáticos para facilitar su comprensión.
- En caso de sospecha de agresión sexual resulta esencial la custodia de la víctima y el aviso al centro médico del eventual traslado en ambulancia, sin llevar a cabo exploraciones innecesarias, así como ilustrar a aquella de la importancia de la preservación de los vestigios que puedan facilitar la prueba de la agresión, para lo que es fundamental evitar que se asee, que se cambie de ropa, que orine y que ingiera alimentos o líquidos hasta ser explorada por el servicio de ginecología o el médico forense.

5. ACTUACIÓN ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA

- Una de las situaciones que mayor conflictividad genera al profesional de la medicina urgente, desde el punto de vista legal, es el de la actuación adecuada ante el fallecimiento de una persona. La muerte puede tener lugar por dos tipos de causas:
 - Muerte natural**, es decir, provocada por un proceso biológico interno de la persona sin la interacción de ninguna causa externa.
 - Muerte violenta**, causada por un agente externo independiente de cualquier proceso natural.
- Salvo en caso de muerte violenta, el facultativo de emergencias deberá remitir inmediatamente al Registro Civil el correspondiente certificado de defunción en el que, conforme ordena el artículo 274 del Reglamento del Registro Civil, además del nombre, apellidos, carácter y número de colegiación del que lo suscriba, se hará constar que existen señales inequívocas de muerte, su causa y, con la precisión que la inscripción

requiere, fecha, hora y lugar del fallecimiento y menciones de identidad del difunto, indicando si es conocido de ciencia propia o acreditada y, en este supuesto, documentos oficiales examinados o menciones de identidad de persona que afirme los datos, la cual también firmará el parte.

- La inadecuada comprensión de la diferencia entre una y otra etiología de la muerte, o en ocasiones la dificultad de una nítida distinción entre ellas, constituye una inagotable fuente de conflictos entre los servicios médicos y el juzgado de guardia y dentro de estos, los institutos de medicina legal, ante la discordancia acerca de la procedencia de certificación de la muerte por parte de los facultativos, o de intervención del juzgado de guardia, y en ella del médico forense, para la tramitación de las correspondientes diligencias penales.
- El acierto o el error en la decisión de certificar la muerte como no violenta o, por el contrario, requerir la presencia del médico forense, tiene consecuencias no solo en la adecuada gestión de los recursos humanos de los juzgados de instrucción, de los institutos de medicina legal y de la policía judicial, sino también en la necesidad de evitar la impunidad de una muerte de origen delictivo, en caso de considerar indebidamente la muerte como no violenta, o de proteger al círculo familiar del fallecido de un sufrimiento adicional innecesario, asociado a las diligencias de levantamiento de cadáver y práctica de la autopsia, si el facultativo considera erróneamente que se trata de una muerte violenta.
- Las causas más frecuentes del desacierto en la decisión de considerar la muerte como violenta cuando se trata de una muerte natural son:

-De un lado, el **desconocimiento del contenido** del propio concepto de muerte violenta, como aquella cuya causa no puede determinar el facultativo con certeza, cuando en realidad solo debe considerarse como tal, motivando la intervención del médico forense y del juzgado de guardia, aquella en la que concurren indicios que contradigan un origen natural del fallecimiento. El desconocimiento del proceso patológico concreto que ha derivado en el fallecimiento, en ausencia de signos de muerte violenta, no constituye un motivo válido para declinar la elaboración del certificado de defunción, porque la enfermedad causal, aunque tenga relevancia clínica, no tiene trascendencia jurídica. En suma, el facultativo no requiere contar con la certeza de la concreta causa de la muerte para denegar la firma del certificado de defunción, sino que únicamente habrá de hacerlo cuando del examen del fallecido y la valoración conjunta de los vestigios y signos externos del lugar en el que ha sido hallado y la información que puedan suministrar familiares o testigos presenciales, concluya que concurren elementos racionales para dudar del origen natural del fallecimiento. En tal caso, el facultativo podrá ser llamado por el órgano judicial durante la investigación y en el juicio oral para declarar como testigo y exponer dichos indicios.

-De otro lado, el **temor a la responsabilidad** en que pudiera incurrir el facultativo por no recabar la intervención del juzgado de guardia, pese a tratarse en realidad de una muerte delictiva, propiciando con ello la impunidad de esta. Dicha responsabilidad deberá valorarse en función de la “Lex Artis”, es decir, de la utilización de criterios racionales y debidamente formados en la toma de decisión sobre la consideración de la muerte como no violenta.

- Con la finalidad de evitar en la medida de lo posible los conflictos y las ineficiencias provocadas por una errónea conceptualización del carácter del fallecimiento por parte del médico de emergencias, en el contexto de las Audiencias Provinciales se vienen constituyendo comisiones integradas por jueces, fiscales, facultativos, médicos forenses y policía judicial para la elaboración de protocolos dirigidos a proporcionar al facultativo el conocimiento y la seguridad jurídica adecuados para poder adoptar la decisión

oportuna de manera eficiente y libre de una sobreestimación del riesgo de incurrir en responsabilidad.

- Como parte de dichos protocolos es común la elaboración de catálogos de supuestos de muerte violenta en los que el facultativo de emergencias ha de recabar la intervención del juzgado de guardia, a saber:

-Sospecha de criminalidad: en caso de advertir manifestaciones externas de violencia, como heridas, signos de lucha o de defensa, estrangulación, fallecido en la vía pública sin acceso a ninguna información sobre las circunstancias de la muerte, o cuando las personas allegadas o los presentes ofrecen explicaciones poco convincentes o no aportan antecedentes.

-Causas traumáticas: como accidentes de tráfico o de trabajo, quemados o electrocutados.

-Asfixia: como ahorcados, ahogados, fallecidos por atragantamiento, aspiración de vómitos o compresión toraco-abdominal.

-Tóxicos: sobredosis por ingesta masiva de drogas, coma etílico, intoxicación alimentaria, laboral o doméstica, o suicidio por ingesta masiva de medicamentos.

-Complicaciones de causa violenta: como neumonía hipostática por fractura de cadera o embolia grasa por fractura de fémur.

-Muerte súbita: en aquellos casos en que el fallecimiento se produce en menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas, sin enfermedades previas que lo puedan explicar y con un buen estado de salud anterior.

- En caso de consideración de la muerte como no violenta, la elaboración del certificado de defunción dependerá de la apertura o no del centro de salud en el momento de su intervención. En caso de apertura, o de horas próximas a ella, debe considerarse que el facultativo de atención primaria que lo tenga asignado como paciente al fallecido cuenta con acceso su historia clínica y mayor información sobre el individuo, por lo que se encuentra en mejor condición para confeccionar el certificado de defunción. Por ello, el servicio de emergencias deberá realizar un informe completo que los familiares del fallecido habrán de entregar en el centro de salud. En caso de coincidencia en el domicilio de los servicios de emergencia y los de atención primaria, deberá elaborar el certificado de defunción este último. Pero si la intervención se produce en horario de atención continuada del Centro de salud, el servicio de emergencias será el encargado de elaborar y redactar del certificado de defunción, y en caso de coincidencia con el servicio de atención continuada del centro de salud, deberá confeccionar el certificado aquel que haya examinado el cadáver con anterioridad.
- El eventual conflicto entre las exigencias de la investigación judicial y la salud de las personas debe resolverse siempre en favor de esta última, de modo que si el servicio de emergencias que se encuentra examinando al fallecido es reclamado para llevar a cabo una intervención que no pueda demorarse deberá ausentarse, a ser posible con el cadáver debidamente custodiado por la policía o de otro modo.

6. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE

- La exposición del profesional sanitario en situaciones de urgencia médica al riesgo de incurrir en responsabilidad es más elevada de lo común por razón del escaso tiempo con el que cuenta para la toma de decisiones, de la gravedad de las situaciones que demandan su intervención, y además, de la frecuente imposibilidad de obtención del consentimiento informado del paciente.
- Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, que debe obtenerse después ofrecer una información adecuada al paciente, quien tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles, y asimismo a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
- Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
- La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.
- El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
- El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.
- Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. El profesional sanitario que acceda de manera injustificada a dicha información está expuesto a responsabilidad penal y disciplinaria. El artículo 197 del Código Penal contempla pena de prisión de 1 a 3 años al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, acceda por cualquier medio a los datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, con previsión de la imposición de la pena en su mitad superior (de 2 a 3 años de prisión) cuando el acceso afecte a datos de carácter personal relativos, entre otros, a la salud.

- Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información adecuada, haya valorado las opciones propias del caso. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
- Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:

-Cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley, si bien una vez adoptadas las medidas pertinentes, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.

-Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

- En caso de menores de 16 años que no sean capaces intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, o en caso de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, o cuando se trate de personas con capacidad modificada judicialmente, prestarán consentimiento sus representantes legales. En caso de mayor de edad que no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación, pero no tenga la capacidad modificada judicialmente, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.